

Doenças Infecciosas na Gestação

Imagine você numa manhã cheia na UBS quando chama a próxima paciente do pré-natal de baixo risco. Ela está com 10 semanas, parece tranquila, mas traz aquele olhar de quem espera que tudo esteja bem. Ao revisar os exames, algo prende sua atenção: um **FTA-ABS positivo** e um **VDRL de 1:32**. Quase sem perceber a gravidade, ela comenta que há dois meses apareceu uma úlcera indolor na vulva que sumiu sozinha. O consultório parece ficar mais silencioso enquanto você conecta as peças. Duas vidas dependem das próximas decisões: a da mãe e a do bebê. Você como médico sabe interpretar esses exames e chegar ao tratamento correto? Com essa aula, tenho certeza que sim.

Sífilis na Gestação

A sífilis é causada pelo **Treponema pallidum**, uma espiroqueta transmitida sexualmente. A doença se divide em três formas clínicas principais: **primária, secundária e terciária**. Além disso, temos a classificação de **sífilis latente recente** (até 1 ano de duração) e **sífilis latente tardia** (mais de 1 ano ou duração desconhecida). Essa classificação não é mero detalhe acadêmico - ela é fundamental porque define o esquema de tratamento.

Voltando à nossa paciente: ela teve uma úlcera há dois meses. Isso caracteriza uma **sífilis latente recente**, pois o contato ocorreu há menos de um ano. Guardem essa informação, pois ela vai determinar quantas doses de penicilina vamos usar.

Comentário crítico: A sífilis é uma epidemia no Brasil, e isso não é exagero. A OPAS já alertou para os casos expressivos acontecendo no país. O que torna isso mais frustrante é que o *Treponema pallidum* é facilmente combatido - **não existe resistência à penicilina**. O problema não é tratamento, é prevenção. A baixa adesão ao uso de preservativos mantém a doença circulando.

Manifestações Clínicas da Sífilis

A **sífilis primária** se manifesta como uma **úlceras genital indolor** com bordas elevadas e fundo límpido - chamamos de lesão "emoldurada". É o clássico **cancro duro**, que pode vir acompanhado de linfonodos regionais aumentados. Aqui está uma pegadinha clássica de prova: essa úlcera regride espontaneamente, **mesmo sem tratamento**. Mas atenção, isso não significa que o corpo "curou" a sífilis. Muito pelo contrário - você continua infectado, apenas sem a manifestação primária da doença.

Na **sífilis secundária**, as manifestações são bem mais diversas e sistêmicas. Você vê **lesões mucocutâneas variadas**: pápulas, placas, o famoso **condiloma plano** (aquela lesão vegetante úmida na vulva), e **alopecia**. Os sinais sistêmicos incluem febre, mal-estar, calafrios e linfonodomegalias generalizadas. As **lesões palmo-plantares** são características: aqueles "alvos" eritematosos com halo branco e centro mais escuro. Detalhe importante que muita gente esquece: **essas lesões transmitem sífilis**. Se você encostar nelas sem proteção, pode se contaminar.

A **sífilis terciária** tem apresentação ainda mais diversa - não é à toa que chamam a sífilis de "a grande imitadora". Você pode ter **lesões cutâneas nodulares e ulceradas**, **lesões ósseas**, **cardiovasculares** (estenose de coronárias e aneurisma de aorta), e **neurológicas** (meningite, atrofia do nervo óptico, alterações psiquiátricas como demência e surtos de psicose, tabes dorsalis).

Diagnóstico de Sífilis

O rastreamento na gestação deve ser feito em **três momentos obrigatórios**: na primeira consulta de pré-natal (idealmente no primeiro trimestre), no início do terceiro trimestre (a partir de 28 semanas), e na admissão para o parto. Essa repetição não é redundância - é prevenção de sífilis congênita.

Se você consegue visualizar o cancro duro, pode fazer a **pesquisa em campo escuro** do *Treponema pallidum*. Você vai ver as espiroquetas na microscopia óptica em campo escuro, e está dado o diagnóstico. Mas na prática, isso é raro. A úlcera é

indolor, as pessoas ignoram, esperam melhorar, e o diagnóstico acaba sendo tardio e sorológico.

O diagnóstico sorológico usa **dois tipos de testes**: os **treponêmicos** (específicos para sífilis) e os **não treponêmicos** (inespecíficos, mas úteis para diagnóstico e monitoramento do tratamento).

Testes treponêmicos: FTA-ABS, TPPA, e o **teste rápido** (mais comum na prática). Uma vez positivos, **sempre serão positivos**, mesmo com tratamento adequado e erradicação completa da infecção. É como uma "cicatriz sorológica".

Testes não treponêmicos: O mais cobrado é o **VDRL**, mas algumas provas gostam de brincar e cobrar o **RPR**.

Pegadinha de prova: O teste treponêmico sempre positiva **primeiro** que o VDRL. Então você pode ter um paciente com teste rápido positivo e VDRL ainda negativo. Isso não exclui sífilis - pode ser apenas janela imunológica para o VDRL positivar. Por isso você **sempre deve fazer testes seriados**.

Interpretando o Perfil Sorológico

Vamos organizar isso de forma prática para você nunca mais errar:

Teste treponêmico REAGENTE + Teste não treponêmico REAGENTE = Diagnóstico de sífilis confirmado. Mas será que foi tratada ou não? O VDRL continua positivo porque: (1) não tratou, ou (2) tratou mas é cicatriz sorológica que ainda não negativou.

Teste treponêmico REAGENTE + Teste não treponêmico NÃO REAGENTE = Algumas possibilidades: (1) não deu tempo do VDRL positivar ainda (janela imunológica), ou (2) tratou tão bem que o VDRL negativou completamente (cicatriz sorológica do treponêmico apenas).

Teste treponêmico NÃO REAGENTE = Não teve contato com sífilis. Não precisa fazer VDRL, não precisa seriar, não precisa fazer nada.

Mensagem de ouro: Teste de sífilis = teste treponêmico. Para saber se a pessoa teve contato com sífilis, você **precisa do teste treponêmico**. O VDRL sozinho **não dá diagnóstico** de sífilis - ele apenas auxilia no diagnóstico (diferenciando tratado de não tratado) e no monitoramento.

Tratamento da Sífilis na Gestação

Aqui não tem negociação, não tem "mas e se". O tratamento de **toda e qualquer gestante com sífilis é penicilina G benzatina**. Acabou. Não existe "vou usar espiramicina", "vou usar doxiciclina". **Não**. O único tratamento para sífilis na gestação, em qualquer lugar do mundo, é a penicilina. É a única que atravessa a barreira placentária com qualidade e eficácia suficiente para tratar também o feto.

E se a paciente for alérgica? **Internação e dessensibilização para penicilina**. Não existe alternativa aceitável.

Esquemas de tratamento:

Sífilis latente recente (até 1 ano de evolução): **1 dose de 2.400.000 UI de penicilina G benzatina intramuscular**. Dose única, acabou.

Sífilis latente tardia (mais de 1 ano ou duração desconhecida): **3 doses de 2.400.000 UI de penicilina G benzatina**, com intervalo de **7 dias** entre as doses (máximo tolerado pelo Ministério da Saúde: 9 dias).

Pegadinha clássica de prova: Se o intervalo entre as doses ultrapassar 9 dias, você **reinicia o tratamento do zero**. Descarta tudo que foi feito anteriormente. Por exemplo: primeira dose no dia 1º de setembro, segunda dose no dia 8 (7 dias depois, tudo certo), mas a terceira dose só aconteceu no dia 22 (14 dias depois da segunda). Que fazer? **Recomeça do zero** no dia 22.

Acompanhamento Pós-Tratamento

A resposta ao tratamento é monitorada pelo **VDRL mensal** na gestante. Os critérios de tratamento adequado são:

- **Queda de 2 diluições** do VDRL em **3 meses**, OU
- **Queda de 4 diluições** em **6 meses** após conclusão do tratamento

Vamos a um exemplo prático: gestante inicia pré-natal com 6 semanas, teste rápido positivo, VDRL de **1:64**. Tratamento iniciado (VDRL de partida: 1:64). No primeiro mês: **1:32** (caiu uma diluição - sempre a metade). Segundo mês: **1:16** (já caiu duas diluições - tratamento adequado!). Terceiro mês: **1:8**. Se ela chega com 40 semanas na maternidade com VDRL de **1:8**, com esse histórico de queda progressiva, isso **não é sífilis ativa**. É sífilis adequadamente tratada. A paciente não está infectada no momento.

Critérios para Retratar

Você deve retratar quando:

- **Não houver** os critérios de tratamento adequado (sem queda esperada das diluições)
- Houver **aumento de 2 diluições** em qualquer momento do seguimento
- **Persistência ou recorrência dos sintomas**

Exemplo: gestante, VDRL inicial 1:64, tratada. Primeiro mês: 1:32 (bom). Segundo mês: 1:16 (ótimo). Terceiro mês: 1:32 (aumentou 1 diluição - ainda ok). Quarto mês: **1:64** (aumentou a segunda diluição - **reinfecção!**). Agora você tem diagnóstico de reinfecção e deve iniciar **retratamento com a mesma posologia** usada para tratar a primeira infecção.

Gestante Adequadamente Tratada

Para uma gestante ser considerada **adequadamente tratada**, ela precisa preencher **todos** esses critérios:

1. Usar **penicilina benzatina** (não pode ser outro antibiótico)
2. Início do tratamento até **30 dias antes do parto**

3. **Esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico** (latente recente vs tardia)
4. **Respeito ao intervalo recomendado** entre as doses (7 a no máximo 9 dias)

Voltando ao caso da UBS: FTA-ABS positivo, VDRL 1:32, histórico de úlcera há 2 meses. Diagnóstico: **sífilis latente recente**. Tratamento: **dose única de penicilina benzatina 2.400.000 UI IM**. Acompanhamento: **VDRL mensal**.

Resolvendo a Questão da Santa Casa

"Acerca das manifestações clínicas da sífilis na gravidez, assinale a alternativa correta."

Alternativa A - "O maior risco de transmissão vertical acontece durante os quadros de sífilis primária e secundária" → **CORRETO**. Durante esses estágios, a infecção está com a maior quantidade de espiroquetas circulantes. Na terciária, essa carga é muito menor. O maior risco de transmissão mãe-bebê é realmente durante os estágios primário e secundário.

Alternativa B - "A sífilis terciária é assintomática e atualmente tem baixa prevalência" → **ERRADO**. Não é assintomática - temos vários sintomas (lesões cutâneas, cardiovasculares, neurológicas).

Alternativa C - "A lesão da sífilis primária é o cancro duro, que apesar de ser uma lesão infectante, é pobre em espiroquetas" → **ERRADO**. Muito pelo contrário - é **rica em espiroquetas**, tanto que conseguimos ver no microscópio.

Alternativa D - "Na sífilis secundária ocorrem lesões cutâneas denominadas goma sifilítica" → **ERRADO**. A goma sifilítica aparece na **sífilis terciária**, não na secundária.

Alternativa E - "Devido a modificações imunológicas próprias da gestação, a apresentação clínica da sífilis pode ser atípica" → **ERRADO**. Não tem relação. A manifestação da sífilis continua sendo do mesmo padrão e típica tanto em gestantes quanto em não gestantes.

Toxoplasmose na Gestação

Agora você está realizando o pré-natal de outra gestante de baixo risco na UBS, com 24 semanas. Sorologia para toxoplasmose: **IgG positivo** e **IgM negativo**. Os exames de primeiro trimestre mostraram exatamente o mesmo padrão: IgG positivo e IgM negativo. A paciente pergunta o que significa esse resultado e o que poderia ser feito.

A **toxoplasmose** é causada pelo **Toxoplasma gondii**, um parasita intracelular obrigatório. O ser humano é hospedeiro intermediário - os hospedeiros definitivos são geralmente bovinos, caprinos e, mais comumente, **gatos**.

Existe uma relação inversamente proporcional muito importante aqui: **quanto maior a idade gestacional, maior a transmissão vertical**. Porém, **quanto mais precoce a infecção na gestação, pior a repercussão fetal**. Consegue entender a lógica? No início da gestação, você tem o desenvolvimento neurológico do feto em plena formação. Uma infecção no primeiro trimestre pode gerar repercussões graves. Já no terceiro trimestre, a chance de transmissão para o feto é maior, mas as consequências tendem a ser menos severas (embora ainda existam).

Manifestações Clínicas da Toxoplasmose Congênita

Repercussões oculares (as mais prevalentes): retinocoroidite, atrofia do nervo óptico, microftalmia, paralisia ocular, catarata e estrabismo. Na imagem de fundo de olho, você vê aquela retinocoroidite característica com áreas de inflamação e cicatrização retiniana.

Repercussões neurológicas: microcefalia, ventriculomegalia (hidrocefalia), surdez neurosensorial, encefalomalácia, porencefalia e **calcificações cerebrais dispersas pelo parênquima**.

Outras repercussões (menos prevalentes mas podem aparecer): hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, oligo ou polidrâmnio, hidropsia fetal.

Gatilho: Retinocoroidite + hidrocefalia + calcificações cranianas difusas no parênquima? Toxoplasmose congênita.

Diagnóstico Sorológico no Primeiro Trimestre

Vamos organizar as possibilidades:

IgM negativo + IgG negativo = Paciente **suscetível**. Não teve contato, não tem imunidade. Conduta: repetir sorologia no terceiro trimestre e orientar medidas de prevenção (não comer alimentos crus, evitar água não tratada, cuidado com contato com fezes de gato).

IgM negativo + IgG positivo = Paciente **imune**. Não tem infecção no momento (IgM negativo) e já teve infecção antes de engravidar (IgG positivo). Conduta: **não precisa nem repetir a sorologia no terceiro trimestre**. Está protegida.

IgM positivo + IgG negativo = **Dúvida**. O IgM positivo sugere infecção aguda. O IgG negativo pode ser porque não deu tempo de formar IgG ainda. Na dúvida, **inicie a espiramicina imediatamente e repita a sorologia em 2-3 semanas**.

Comentário crítico: A questão da Unicamp traz exatamente esse cenário - gestante com 12 semanas e 4 dias, IgM positivo, IgG negativo. Qual conduta? **Repetir sorologia em 2-3 semanas** (a espiramicina o próprio enunciado já disse que foi iniciada). Nunca fique esperando confirmar para tratar - na dúvida, trata e confirma depois.

O Cenário Mais Cobrado em Provas

IgM positivo + IgG positivo = É infecção aguda ou infecção antiga? O IgM positivo pode estar ali porque a paciente foi infectada há muito tempo e o IgM ainda não negativou. O IgG positivo porque teve contato. Fica a dúvida.

A solução: solicitar **teste de avidéz para IgG**.

Avidez ALTA = Imunoglobulina G "velha", está ali há muito tempo. Infecção antiga, paciente imune. **Não precisa tratar.**

Avidez BAIXA = Infecção recente nesta gestação. **Precisa tratar.**

Tratamento da Toxoplasmose

O tratamento varia conforme a idade gestacional no diagnóstico:

Diagnóstico antes de 16 semanas (com avides baixa confirmando infecção recente):

- Iniciar **espiramicina** 3g/dia
- A espiramicina **evita a passagem do Toxoplasma do sangue materno para o sangue fetal**
- Após 16 semanas, trocar para o **esquema tríplice**: sulfadiazina + pirimetamina + **ácido folínico** (nunca ácido fólico!)
- Manter esquema tríplice até **18 semanas de gestação**
- Com 18 semanas completas, solicitar **PCR do líquido amniótico** (amniocentese)

Se PCR do líquido amniótico for NEGATIVO: voltar com espiramicina até o parto. Por que trocar de volta? Porque não deu tempo do Toxoplasma passar para o sangue fetal. Então mantemos apenas profilaxia.

Se PCR do líquido amniótico for POSITIVO: manter sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico até o parto. É a única combinação que consegue tratar mãe e feto simultaneamente.

Diagnóstico no segundo/terceiro trimestre (após 16 semanas):

- Já iniciar o **esquema tríplice** (sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico)
- Manter até o parto
- **Sem necessidade de amniocentese** se o diagnóstico foi após 28 semanas

Pegadinha importante: Sempre usar **ácido folínico**, nunca ácido fólico. A pirimetamina inibe a síntese de ácido fólico, e o ácido folínico repõe isso sem interferir na ação antiparasitária.

A partir do diagnóstico de infecção por toxoplasmose, deve-se **seriar ultrassom obstétrico** para identificar alterações fetais (calcificações intracranianas, ventriculomegalia).

Resolvendo o Caso da UBS

Gestante com 24 semanas, IgG positivo e IgM negativo. Os exames do primeiro trimestre já eram IgG positivo e IgM negativo. Diagnóstico: **toxoplasmose prévia à gestação** (IgG positivo = teve contato no passado; IgM negativo = não tem infecção aguda atual). A paciente está **imune**. Conduta: explicar que ela teve contato com toxoplasmose antes de engravidar, está protegida, e **não precisa de tratamento nem de novas sorologias**.

HIV na Gestação

Agora um cenário de urgência: gestante com 35 semanas e 2 dias chega à maternidade com contrações uterinas intensas e muita cólica. Refere perda de tampão mucoso, nega perda de líquido, movimentação fetal preservada. Não fez pré-natal. Ao exame: bom estado geral, PA e FC normais, altura uterina 33cm, BCF 144bpm (normal: 110-160), **dinâmica uterina com 4 contrações fortes de 45 segundos a cada 10 minutos** (trabalho de parto franco!). Toque vaginal: colo medianizado, 100% esvaecido (fino como uma folha de papel), **6cm de dilatação**, apresentação cefálica, bolsa íntegra. Tipagem sanguínea O positivo. **Teste rápido de HIV positivo**. Demais exames normais. Iniciada zidovudina EV e penicilina cristalina. Qual a conduta obstétrica?

O **HIV** (vírus da imunodeficiência humana) tem diagnóstico preconizado pelo Ministério da Saúde com **teste inicial + teste molecular complementar sequencial**. Se o primeiro teste vier positivo, você repete o segundo. Se vier positivo também,

está confirmado o diagnóstico. Se o primeiro vier negativo, nem precisa fazer o segundo - diagnóstico excluído. O teste deve detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2, além do **antígeno P24 do HIV-1** em até 15 dias após a exposição.

Transmissão Vertical do HIV

A transmissão vertical é **mais comum no terceiro trimestre e durante o parto**, porque há maior fluxo sanguíneo placentário nesses momentos. A transmissão também ocorre pelo **leite materno**, por isso a amamentação é **contraindicação absoluta** em mães HIV positivo.

O principal fator de transmissão vertical é a carga viral materna: quanto mais alta a carga viral, maior a chance do feto se infectar.

Manejo da Gestante com HIV

Uma gestante com HIV requer **equipe multidisciplinar completa**: assistente social, psicólogo, infectologista, obstetra, agente comunitário de saúde. Ela não pode perder seguimento - um único mês sem tomar antirretroviral pode elevar a carga viral rapidamente.

Exames trimestrais: hemograma, função renal, função hepática, sorologia para toxoplasmose (para as não imunes), urina 1 e urocultura.

Sorologias específicas:

- Hepatite A e Chagas em **grupos de risco** (áreas sem saneamento básico para hepatite A, áreas endêmicas para Chagas)
- Pesquisa de tuberculose para **pacientes sintomáticas e grupo de risco**

Vacinas Recomendadas (importante para Preventiva!)

- Hepatite B
- Covid-19
- Influenza

- **Pneumococo, meningococo e Haemophilus** para mulheres menores de 19 anos não vacinadas previamente
- **Hepatite A** para gestantes suscetíveis em área endêmica

Exames na Primeira Consulta

Se gestante com diagnóstico de HIV na gestação ou carga viral detectável: solicitar **carga viral, genotipagem e CD4**.

Genotipagem pré-tratamento é obrigatória para toda gestante que vai iniciar TARV (terapia antirretroviral). Isso identifica possíveis resistências virais e guia o esquema terapêutico.

Para gestantes soropositivas com **carga viral indetectável** (aquelas que fazem tratamento adequado): seriar carga viral a cada 4 semanas até a negatificação, depois repetir com **34 semanas**.

Tratamento padrão: dolutegravir + lamivudina + tenofovir. É o mesmo esquema de qualquer adulto infectado pelo HIV sem contraindicações.

Manejo Obstétrico e Via de Parto

Toda gestante com HIV deve ter carga viral colhida com 34 semanas. Essa carga viral define a via de parto:

Carga viral > 1000 cópias com 34 semanas:

- **Cesárea eletiva com 38 semanas**
- Membranas íntegras (não estoura a bolsa - mantém o máximo possível durante o procedimento)
- Iniciar **AZT (zidovudina) EV 3 horas antes do parto** até clampeamento do cordão

Carga viral < 1000 cópias com 34 semanas:

- Via obstétrica **livre** (pode ser parto vaginal ou cesárea)
- Depende da indicação médica e combinação com a paciente
- Se carga viral **detectável** (mesmo que < 1000): fazer AZT EV 3 horas antes até clampeamento
- Se carga viral **indetectável**: não precisa AZT

Comentário crítico: A Unicamp nessa questão esperava que você percebesse a malícia. A paciente está com **6cm de dilatação, dinâmica de 4 contrações fortes em 10 minutos, colo 100% esvaecido**. Isso é **franco trabalho de parto**. Vai nascer. Não adianta tentar cesárea de urgência - você deixa nascer por via vaginal. A banca quer que você pegue essa sacada do examinador: não submeta a paciente a uma cesárea desnecessária quando o parto vaginal é iminente.

Resposta da questão da Unicamp: Conduta obstétrica = **parto vaginal**.

Quadro Resumo - HIV

- Carga viral > 1000 cópias = cesárea eletiva + AZT EV
- Carga viral < 1000 cópias = via livre (preferencialmente vaginal) + AZT EV se detectável
- Carga viral indetectável = via livre, sem AZT
- Tratamento padrão: dolutegravir + lamivudina + tenofovir
- Contra-indicação absoluta: amamentação

Hepatite B na Gestaç o

O v rus da hepatite B   um **DNA-v rus** com uma caracter stica preocupante: **quanto mais precoce a infec  o, maior a taxa de cronifica  o**. Chega a **90% de cronifica  o para transmiss es perinatais** (infec  o durante a gesta  o). Por isso   t o importante diagnosticar e tratar adequadamente.

Rastreo: **HBsAg positivo** no primeiro e no terceiro trimestre confirma diagnóstico de infecção por hepatite B. Toda gestante deve tomar o **esquema completo de hepatite B** (pelo menos 3 doses).

Manejo da Gestante com HBsAg Positivo

Se você tem uma paciente com **HBsAg positivo**, as provas querem saber o que você faz:

Solicitar: **ALT (TGP), HBeAg e carga viral**.

Cenário 1 - ALT normal + HBeAg negativo + carga viral < 200.000 cópias:

- Seguimento com **ALT trimestral** (para identificar lesão hepática)
- Repetir **HBeAg e carga viral com 28 semanas**
- Se não houver progressão (HBeAg continua negativo, carga viral continua < 200.000), **não precisa antirretroviral**

Cenário 2 - HBeAg reagente OU carga viral > 200.000 cópias OU ALT > 2x o limite superior da normalidade OU coinfeção com HIV:

- Iniciar **tenofovir a partir de 28 semanas até o parto**
- Objetivo: evitar transmissão vertical

Manejo no Puerpério

Hepatite B **não** é contraindicação para parto vaginal. **Não** é contraindicação para amamentação.

Todo RN que nasce de mãe infectada pelo vírus da hepatite B, independentemente de ter feito profilaxia ou não com tenofovir, deve tomar **vacina + imunoglobulina anti-hepatite B**.

Quadro Resumo - Hepatite B

- Rastreio universal com HBsAg
- Se HBsAg positivo → solicitar USG, ALT, HBeAg e carga viral
- Tratamento indicado se: HBeAg positivo OU carga viral > 200.000 OU ALT > 2x LSN OU coinfeção HIV
- Tratamento: tenofovir a partir de 28 semanas até o parto

Streptococcus do Grupo B (Streptococcus agalactiae)

O **Streptococcus do grupo B** (GBS) é um Streptococcus beta-hemolítico, gram-positivo, que coloniza tanto o trato genital feminino quanto a região intestinal de homens e mulheres. É a **principal causa de sepse neonatal precoce**, além de endometrite puerperal (infecção uterina pós-parto).

Aumenta o risco de **infecções perinatais**: ruptura prematura de membranas (bolsa rota precoce), parto prematuro, ITU, corioamnionite, endometrite e sepse neonatal.

Rastreio universal: a partir de **35 semanas** com **swab anal e vaginal** para todas as gestantes.

Indicações de Antibiótico Profilaxia Intraparto

Aqui está o que as provas realmente querem saber de você: quando fazer profilaxia antibiótica (penicilina ou ampicilina) intraparto?

Se a cultura for desconhecida (gestante chegou em trabalho de parto sem ter feito cultura), fazer profilaxia se:

- Raça negra (recomendação oficial do MS, embora questionável)
- **RN anterior com sepse precoce por GBS** (se a mãe já teve um bebê com infecção por GBS, sempre faz profilaxia)
- **Exame de urocultura nesta gestação mostrou GBS** (bacteriúria assintomática por GBS)

- **Trabalho de parto ou ruptura de membranas prematura** (< 37 semanas - bolsa rota em gestante com < 37 semanas, faz profilaxia sempre)
- **Bolsa rota > 18 horas** em gestante a termo
- **Febre durante o trabalho de parto**

Se a cultura for positiva para GBS: fazer profilaxia **independentemente da condição clínica**.

Antibiótico de escolha: **penicilina cristalina** até o nascimento ou por 48 horas (considera-se que erradicou o GBS da região genital).

Dose: 5 milhões UI (ataque), depois manutenção de 2,5 milhões a cada 4 horas até o nascimento.

Quando NÃO tratar

- Gestante submetida a **cesárea** (bebê não passa pelo canal vaginal)
- Cultura **negativa** ou **fora de trabalho de parto**
- Intervalo entre trabalho de parto e cultura negativa > **5 semanas** (considera desconhecida, precisa coletar nova cultura - validade de 5 semanas)

Arboviroses na Gestação

As **arboviroses** (dengue, zika e chikungunya) são doenças de interesse nacional, já que são muito endêmicas no Brasil. O vírus da **dengue** e o vírus da **zika** têm repercussões clínico-fetais muito importantes.

Vetores: mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. A transmissão também pode ocorrer por transfusão sanguínea e sexual (principalmente no caso da zika).

Diagnóstico

Diagnóstico é **clínico e epidemiológico**: gestantes sintomáticas que tenham estado em áreas endêmicas. Se ela tem febre, artralgia, exantema e frequentou área endêmica de dengue, ela tem critério epidemiológico e clínico.

Manifestações clássicas: exantema, artralgia, dor retroorbitária, cefaléia, febre alta, desidratação, taquicardia.

Diagnóstico laboratorial:

Dengue: Estágio inicial (até 4 dias) - **NS1** ou RNA viral. Após 7 dias - sorologias IgM e IgG.

Zika: Estágio inicial - **RNA viral em amostra urinária** da gestante. Após 14 dias - IgM e IgG.

Chikungunya: Diagnóstico pelo **RT-PCR**.

Tratamento

Como toda infecção viral, a maioria não tem tratamento específico - é direcionado aos sintomas. **Gestante é grupo B** no tratamento para dengue (requer atenção especial). Vale dar uma olhada no fluxograma de tratamento para dengue do Ministério da Saúde.

Complicações Fetais

Dengue: aborto, prematuridade, restrição de crescimento fetal, transmissão vertical (rara, mas pode acontecer), transmissão sexual também.

Zika: **microcefalia** (a mais importante), calcificações parenquimatosas subcorticais, ventriculomegalia, deformidades oculares, deficiência auditiva, deficiência visual, trabalho de parto prematuro, morte perinatal, miocardite, alterações articulares,

alterações dermatológicas, hiperalgesia grave, hipertermia e plaquetopenia acentuada.

Gestante infectada por zika deve fazer ultrassom mensal a partir do terceiro trimestre para identificar essas alterações.

Via de Parto

Não se indica cesárea só porque está infectada por zika. A via de parto é **obstétrica** - vai depender do que o médico achar mais conveniente no momento.

Resumo dos Gatilhos

Sífilis:

- Diagnóstico = teste treponêmico + não treponêmico
- Tratamento guiado pelos estágios: latente recente (1 dose 2.400.000 UI), latente tardia/terciária (3 doses 2.400.000 UI)
- Intervalo entre doses: 7 a no máximo 9 dias (se ultrapassar, reinicia do zero)
- VDRL mensal para acompanhamento
- Critério adequadamente tratada: penicilina benzatina, dose correta, até 30 dias antes do parto

HIV:

- Carga viral com 34 semanas define via de parto
- CV > 1000 cópias = cesárea + AZT EV
- CV < 1000 cópias = via livre
- CV detectável (mesmo < 1000) = AZT EV
- CV indetectável = sem AZT
- Tratamento: tenofovir + lamivudina + dolutegravir

Toxoplasmose:

- Tríade clássica: retinocoroidite + hidrocefalia + calcificações cranianas dispersas
- IgM + IgG positivos até 16 semanas = solicitar avidéz para IgG
 - Avidéz alta = imune, não trata
 - Avidéz baixa = infecção recente, trata
- Tratamento: espiramicina até 16 semanas, depois esquema tríplice
- PCR em líquido amniótico com 18 semanas
- IgG positivo + IgM negativo no 1º trimestre = imune, não repetir sorologia

Essa aula cobriu as principais doenças infecciosas na gestação. O segredo para dominar esse tema é entender a lógica dos fluxogramas diagnósticos e terapêuticos, não apenas decorar. Com isso, você estará preparado tanto para a prova quanto para o atendimento na vida real. Bons estudos!